Gap-analyse: CRM API-laag vs. ontwerp Kliniekportaal (Herniapoli)

- **Status:** analyse, eerste open vragen beantwoord (2026-10-29); nog geen bouw
- **Besluiten (2026-10-29):**
  - Patiëntbegeleider komt **niet** in het portaal.
  - De arts wordt CRM-gebruiker en wordt **toegekend aan een sale** (SalesLead). Dat bestaat nog niet en is onderdeel van de gap (G-1a).
  - Patiënten en dossiers aanmaken gebeurt **in het CRM**, niet in het portaal.
  - De opmerking "CRM-integratie geparkeerd" in het monday-project is een oud besluit en vervalt.
  - **Eén arts per sale, verplicht, alleen voor Herniapoli.** Privatescan-sales krijgen deze relatie niet (geen operaties).
  - **De arts heeft een relatie met een kliniek** (te bouwen). Daarmee ligt vast welke patiënten een kliniek mag zien: kliniek → artsen van die kliniek → hun sales. Meerdere klinieken zijn dus mogelijk en worden gescheiden.
  - Een arts werkt bij **één** kliniek (`users.clinic_id`).
  - De arts is **verplicht vanaf de overgang naar "Casus bij arts ter beoordeling"**, niet bij het aanmaken van de sale.

1. Uitgangspunten

Bron van het ontwerp: `~/Downloads/Herniapoli-monday` (v45 Draft). Dit is een werkende monday.com-app. Het datacontract komt daarom uit code en niet uit losse mockups:

Bron	Wat het vastlegt
`apps/herniapoli-gateway/src/routes/dispatch.js`	alle ≈ 60 operaties die de frontend aanroept
`shared/resource-map.js`	≈ 70 logische velden, documentregels en planningsconstanten
`shared/access-model.js`	rollen, capabilities en veldcategorieën
`docs/HOME_ROLSCHERMEN.md`	het datacontract van Home per rol
`docs/benutzerhandbuch-klinik`, `gebruikershandleiding-arts`, `-zorgadviseur`	schermen en workflows (screenshots en tekst)
`docs/00_Procelsio_monday_Master_Blueprint_v1.1.docx`	de functionele waarheid (besluiten)

Scope (afgesproken):

- Het kliniekportaal is één portaal voor de rollen **Kliniek**, **Arts** en **Zorgadviseur**, elk met een eigen rol en mogelijk eigen schermen.
- **Patiënten krijgen geen toegang** tot het kliniekportaal. Het patiëntportaal blijft los bestaan.
- Een groot deel blijft in de huidige structuur. De Document Studio (Arztbrief) en de Rezept Studio blijven generatoren aan de portaalkant. Het CRM bewaart alleen het resultaat als bestand.
- **Een recept gaat als file-activiteit naar het patiëntportaal.** Daarvoor bestaat al het mechanisme `activity_portal_persons` + `PatientNotification`.

Buiten scope: de rollen Patiëntbegeleider en Beheerder uit het ontwerp (besloten), patiënten en dossiers aanmaken vanuit het portaal (dat blijft in het CRM), migratie van monday-data, en het dashboard.

---

2. Domeinvertaling monday → CRM

Het ontwerp gebruikt twee monday-borden. Dit is de vertaling naar ons model. Een gap-regel verwijst hiernaar.

Ontwerp (monday)	CRM	Opmerking
Patiënt (recordtype op patiëntenbord)	`Person`	naam, voornaam en geboortedatum aanwezig
Behandeltraject (LWS/HWS-dossier)	`SalesLead` met `department = Herniapoli`	één patiënt kan meerdere trajecten hebben; dat klopt al (`lead_persons`/`persons()`)
Regio (LWS / HWS)	niet als veld; af te leiden uit `FormType::HerniaBackPainForm` / `HerniaNeckPainForm`	**gap**, zie G-2
Werkstatus (10 statussen, "wie is aan zet")	`SalesLead.pipeline_stage_id` (Hernia-saleslijn)	**andere as**, zie G-3
Diagnose / Behandlungsberatung	niet aanwezig; wel `assessment_outcome` (code)	**gap**, zie G-2
Operatie-afspraak (operatiebord)	`Order` (Hernia-orderlijn) + `OrderItem` (partnerproduct, bv. "PTED - operatie 1 niveau") + `ResourceOrderItem` (from/to op een `Resource`)	basis aanwezig
Consult / Nacontrole	`OrderItem` met partnerproduct "Consultgesprek arts" / "Nacontrole Dr. Jost Thissen" + boeking	aanwezig, te verifiëren of dit zo gebruikt wordt
Operatierecord (klinische historie per operatie)	`Order` zelf	klinische velden ontbreken, zie G-5
Vrij slot / capaciteit	`Resource` + `Shift` (beschikbaarheidsblokken)	ander concept: geen losse slot-items, zie G-4
Planningsstatus Optie / Ingepland / Geannuleerd	`OrderItemStatus` + orderfase	"Optie met vervaldatum" ontbreekt, zie G-4
Kliniek (Procelsio)	`Clinic` "Procelsio Clinic GMBH" + `ClinicDepartment`	aanwezig
Bestandskolommen (Diagnoseformulier, 1e MRT, AFB, ...)	`Activity type=file` + `additional.document_type`; deels eigen modellen (Anamnesis/GVL-form, `AfbPersonDocument`, `leads.diagnoseform_pdf_url`)	verspreid, zie G-6
Updates/chat per dossier (draad, @mention, bijlage)	`Activity type=note` op sales_lead (plat)	**gap**, zie G-7
Interne notitie	`Activity type=note`	aanwezig
Inbox/meldingen voor medewerkers	niet aanwezig (`PatientNotification` is alleen voor patiënten)	**gap**, zie G-8
Anesthesiestatus / -formulier	`FormType::HerniaNarcoseForm` (GVL-flow op Anamnesis/Order)	formulier wel, beoordelingsstatus niet, zie G-5

---

3. Huidige API-laag (stand op branch `feat/mbs-505-…`)

`routes/api.php`: alle routes staan achter `api.key`.

Groep	Endpoints	Auth
Leads	`POST leads/hernia`, `POST leads/privatescan`, `GET/PUT/DELETE leads/{id}`, stage, notes, activities, forms	alleen X-API-KEY
Sales-leads	`POST sales-leads`, `GET/POST sales-leads/{id}/activities`	alleen X-API-KEY
Patiënt (portaal)	`patient/{id}/messages, counters, appointments, documents (+upload/download), notifications, naw, password, preferences`	Keycloak Bearer **alleen voor eigen subject** (`patient.self`)
Overig	webhooks, keycloak-mapping, 2FA-code, forgot-password, failed-jobs	alleen X-API-KEY

Kernconclusie: de API heeft twee soorten ingangen:

1. **Service-to-service** (API-key), zonder gebruikersidentiteit en zonder rechten per gebruiker.
2. **Patiënt-self**, waarbij een token alleen bij de eigen gegevens kan.

Er is **geen ingang voor een ingelogde medewerker (kliniek, arts of zorgadviseur) met rolgebaseerde rechten.** `ApiKeyAuth::allowsKeycloakBearerFallback()` laat een bearer-token bewust alleen toe op `api/patient/*`. Dat is gap G-1, en alle andere gaps hangen ervan af.

De bouwstenen voor die ingang zijn er al: Keycloak-clients `clinic-app` en `employee-app` (`KeyCloakClient`) en de realm-rollen `clinic` en `employee` (`KeycloakRoles`).

---

4. Gaps

Legenda: ✅ aanwezig · 🟡 deels / alleen in admin-web (sessie) · ❌ ontbreekt

G-1 Authenticatie en autorisatie voor medewerkers ❌ (blokkerend)

Ontwerp	CRM	Gap
Ingelogde gebruiker met rol advisor / doctor / clinic (`roles.current`)	Keycloak-clients `clinic-app` / `employee-app` bestaan; API accepteert hun token niet	Bearer-auth voor medewerkers op een nieuwe routegroep, gekoppeld aan een CRM-`User`
Capabilities per rol (≈ 40, zie `access-model.js`)	Webkul `Role` + ACL-permissies (admin-web)	capabilities voor het portaal bepalen; Laravel Policies/Gates op de API
Veldrechten per categorie (medisch / kliniek / administratief / financieel)	niet aanwezig	**Advies:** niet het hele veldclassificatiemodel kopiëren. Per rol een vaste API Resource; "financieel" (OP-techniek, prijzen) nooit in portaal-resources
Bereik: kliniek ziet alleen eigen patiënten	geen koppeling User ↔ Clinic	kliniekgebruiker én arts koppelen aan `Clinic`; scope via arts → sale (zie G-1a)
`session.ping`, `home.versie` (polling)	—	`GET /me` volstaat; versie-polling zie G-9

G-1a Arts als gebruiker, toegekend aan een sale ❌ (besloten, nog niet gebouwd)

Een arts ziet in het portaal **alleen de trajecten waaraan hij is toegekend**. Op dit moment:

- `SalesLead.user_id` is de eigenaar (de zorgadviseur). Er is geen veld voor een behandelend arts.
- Een arts bestaat nog niet als CRM-`User` met een eigen rol.

Wat er nodig is:

Onderdeel	Gap
`salesleads.doctor_user_id` (FK → users), relatie `SalesLead::doctor()`. Eén arts per sale	❌
Verplicht voor Herniapoli-sales vanaf de overgang naar "Casus bij arts ter beoordeling" (`sales-intake-hernia`), en in alle fases daarna. Nooit voor Privatescan (`SalesLead::isHerniaPoli()`). Afdwingen op elke route die de fase zet (admin-update, stage-wissel, API, automatisering); bij voorkeur op één centrale plek die al die routes gebruiken. Aanmaken zonder arts mag, zodat de automatische flow bij een gewonnen lead blijft werken	❌
Bestaande Herniapoli-sales hebben nog geen arts: een **backfill** (eenmalig toekennen) voordat de verplichting aan gaat	❌
CRM-rol "Arts" (Webkul `Role`) + Keycloak-rol/groep, zodat de arts via het portaal inlogt	❌
Arts toekennen in de CRM-admin (sale-detail; ook in bulk, voor de bestaande werkvoorraad)	❌ (CRM-UI, geen portaal-API)
Wijziging van de toekenning in het Wijzigingslogboek (audit trail)	✅ via `HasAuditTrail`

Arts ↔ kliniek (te bouwen):

Onderdeel	Gap
`users.clinic_id` (FK → clinics, nullable): één kliniek per arts, en ook voor de kliniekgebruiker	❌

Onderdeel	Gap
Verplicht voor gebruikers met rol Arts of Kliniek	❌
Beheer in de CRM-admin (gebruiker bewerken: kliniek kiezen)	❌

Scope per rol, afgeleid uit deze twee relaties:

Rol	Ziet
Zorgadviseur	alle Herniapoli-sales (gezamenlijke werkvoorraad, blueprint)
Arts	sales met `doctor_user_id = ik`
Kliniek	sales waarvan de arts bij de eigen kliniek hoort: `doctor.clinic_id = mijn clinic_id`

Deze scope zit als één query-scope (`SalesLead::scopeVisibleInPortalFor(User)`) plus Policy op alle portaal-endpoints: trajecten, afspraken, documenten, chat en Home. Afspraken en documenten erven hun zichtbaarheid van de sale; ze krijgen geen eigen check.

Let op: een operatie wordt ingepland op een `Resource` → `ClinicDepartment` → `Clinic`. Bij het plannen moet die kliniek gelijk zijn aan de kliniek van de arts. Anders ziet de kliniek waar de operatie plaatsvindt de patiënt niet. Voorstel: bij het boeken valideren en een afwijking weigeren.

Voorstel: een aparte routegroep `api/portal/*` met middleware `keycloak.staff`. Die valideert het token, vindt de `User` via `keycloak_user_id` of e-mail, controleert de rol (`clinic`, `employee` + portaalrol) en weigert alles zonder rol. API-key-callers horen hier **niet** toegang te krijgen.

G-2 Behandeltraject (SalesLead) als dossier 🟡

Ontwerp-operatie	CRM	Gap
`patients.list` / `itemsOpen` / `itemsAfgerond` (werkvoorraad: patiënt + open trajecten, kaartgegevens)	admin-web kanban `/admin/sales-leads`; geen API-index	❌ `GET portal/trajectories?status=open|closed&q=` (gepagineerd, lichte kaartvorm)
`patients.detail` / `trajectory` (dossierkop + overzicht)	`SalesLead` + persons + anamnesis	❌ `GET portal/trajectories/{id}`
`patients.itemsPatienten` / `patients.create` / `patients.addTrajectory` (patiënt of dossier aanmaken + duplicaatcontrole)	lead → sales-flow + duplicaatdetectie in het CRM	✅ **geen gap:** dit blijft in het CRM (besloten). Het portaal kan een knop "openen in CRM" tonen
Veld **Regio** (LWS/HWS)	niet aanwezig	❌ kolom op `salesleads` of afleiden uit formuliertype
Veld **Diagnose** (long text, arts)	niet aanwezig	❌ kolom op `salesleads`
Veld **Behandlungsberatung** (long text, arts)	niet aanwezig (`assessment_outcome` is alleen een code)	❌ kolom op `salesleads`
Veld **Trajectnummer**	—	❌ of `salesleads.id` gebruiken (voorstel: id)
Veld **Siehe Chat** (checkbox)	niet aanwezig	❌ boolean op `salesleads`
`patients.updateField` (één veld, met optimistic lock `verwacht`)	—	❌ `PATCH portal/trajectories/{id}` met whitelist per rol + `updated_at`-check (409 bij conflict)
Historie mag nooit overschreven worden	audit trail (`HasAuditTrail`) + Wijzigingslogboek	✅ wijzigingen loggen als system activity

G-3 Werkstatus ❌ (besluit nodig)

Het ontwerp kent **10 werkstatussen** die zeggen wie aan zet is:

Werkstatus (ontwerp)	Bestaande Hernia-salesfase
Casus bij arts ter beoordeling	✅ `sales-intake-hernia` "Casus bij arts ter beoordeling"
Beoordeling gereed	✅ `sales-mri-beoordeling-hernia` "Beoordeling gereed"
Vraag aan arts / Vraag beantwoord	❌
Artzbrief nodig / Arztbrief verzendklaar	❌
OP-verslag nodig / OP-verslag verzendklaar	❌
Wachten	🟡 deels (bedenktijd, zorgverzekeraar)
Afgerond	✅ succes/niet succesvol afgerond

De CRM-fases beschrijven de **traject-levenscyclus** (bedenktijd, gepland, nazorg). De werkstatus is een **taak-as** die er dwars doorheen loopt: een traject in "1e Nazorg" kan tegelijk "OP-verslag nodig" hebben.

Advies: een aparte kolom `salesleads.work_status` (enum, 10 waarden) naast de pipeline-fase. Voeg geen fases toe, want dan breekt de analytics-sync (`003_sync_procedure.sql`). Endpoint: `PUT portal/trajectories/{id}/work-status`, met de "controle bij het sluiten" uit de handleiding server-side. Home-blokken (G-9) filteren op deze kolom.

G-4 Planning: operaties, consulten, nacontroles, capaciteit 🟡

Planning bestaat in het CRM, maar alleen in admin-web (`OrderItemPlanningController`, `ResourcePlanningMonitorController`, sessie-auth).

Ontwerp-operatie	CRM	Gap
`operations.week` / `items` (weekoverzicht: per dag operatie-, intake-, consult- en nacontrolekaarten)	planning-monitor (admin-web)	❌ `GET portal/appointments?from=&to=` met type, status, patiënt, behandeltype en kamer
`operations.detail` (afspraakvenster, 3 tabs)	`Order` + items + boekingen	❌ `GET portal/appointments/{id}`
`operations.forTrajectory`	`SalesLead.orders()`	❌ `GET portal/trajectories/{id}/appointments`
`operations.freeSlots`	`.../availability` (admin-web)	🟡 ontsluiten als `GET portal/availability?from=&days=`
`operations.claimSlot` / `plan` (operatie of consult inplannen; status Optie/Ingepland; behandeltype; intakedatum; aankomsttijd)	`book` (admin-web); Order + OrderItem aanmaken	🟡 ontsluiten; **Intake-datum** en **aankomsttijd** hebben geen duidelijke plek (`first_examination_at/_time`?, te verifiëren)
Status **Optie** + **Optie vervalt**	`OrderItemStatus` heeft geen optie-met-vervaldatum	❌ status + `option_expires_at` + job die verlopen opties vrijgeeft
`operations.cancel` (met reden, historie blijft, optioneel vervangen)	OrderItem-status lost + `lost_reason`	🟡 ontsluiten; reden verplicht
`operations.update` (planningsvelden wijzigen)	`admin.orders.update`	🟡 ontsluiten met whitelist
`operations.capacity` / `capacityDelete` (vrije slots aanmaken/verwijderen, max 20/dag, 180 dagen vooruit)	`Shift` (periode + tijdblokken) op `Resource`	🟡 **conceptverschil:** het ontwerp maakt losse slots (Slot 1..n per dag), het CRM werkt met beschikbaarheidsvensters. Advies: het CRM-model houden en de portaal-UI slots laten afleiden uit Shift + boekingen. Capaciteitsbeheer in het portaal alleen voor de rol die het echt doet (V4)
Weekgroep, slotnummer	monday-artefacten	geen gap; niet overnemen

G-5 Operatierecord: klinische velden per operatie ❌

Het ontwerp legt per operatie blijvende klinische data vast. De kliniek vult die in; het Home-blok "Entlassungsdaten erfassen" schrijft hierheen.

Veld (ontwerp)	CRM	Gap
Behandelingstype (PTED 1 niv., Mikro 2 niv., TLIF, ACDF, ...)	`OrderItem.partner_product_id`	✅ afleidbaar
Werkelijke OP-tijd	`ResourceOrderItem.from` is gepland, niet werkelijk	❌
Kamernummer	—	❌
Voorovernachting (Übernachtung / Tagesaufenthalt)	partnerproduct "PTED - medische overnachting" als orderregel?	🟡 te verifiëren; anders boolean
Zelfoplossende hechtingen	—	❌
Bijzonderheden opname	—	❌
Ontslagdatum / ontslagtijd	—	❌
Medicatie tijdens opname / meegegeven / receptvoorschrift	—	❌ (long text)
Anesthesiestatus (akkoord / actie nodig / nog niet beoordeeld) + toelichting	Narcoseformulier via GVL-flow, geen beoordelingsstatus	❌ status + toelichting
Aangemeld bij kliniek / documenten opgehaald door kliniek	AFB-verzending (`AfbDispatch.status`, `sent_at`)	🟡 "aangemeld" ≈ AFB verstuurd; "opgehaald" ❌ (bijvoorbeeld download-timestamp loggen bij portal-download)
Tijd bevestigd aan patiënt	`OrderPersonConfirmation`	🟡 te verifiëren
OP-techniek (financieel)	—	nooit in het portaal tonen

Advies: één tabel `order_clinical_records` (1:1 met `Order`, of per OrderItem bij meerdere operaties per order, zie V5) met de kolommen hierboven. Endpoints: `GET/PATCH portal/appointments/{id}/clinical-record`. Daarbij **velden per rol**: de kliniek schrijft dag-, opname- en ontslagvelden, de arts schrijft medicatie en recept. Bij oudere records alleen lezen (blueprint: historie nooit overschrijven).

G-6 Documenten 🟡

Het ontwerp kent **vaste documentregels** per dossier en per operatie. Home toont per aanmelding of de verplichte documenten aanwezig zijn (✓ Diagnoseformulier, ⚠ AFB, ...).

Documentregel	Waar nu in CRM	Gap
Diagnoseformulier	`leads.diagnoseform_pdf_url` / Anamnese-formulier (patiëntportaal)	🟡 één bron kiezen en ontsluiten
1e / 2e / 3e MRT, CT-Bilder, MRT-Befund (ook **externe viewerlinks**)	file-activiteiten, ongetypeerd	🟡 `document_type` vullen; links als type `link` ❌
Arztbrief I / II, 1e/2e Procelsio-Arztbrief	—	❌ upload vanuit Document Studio
Recept	—	❌ upload + **delen met patiëntportaal** (zie G-6a)
OP-bericht, Procelsio OP-bericht, Behandlungsverlauf	`admin.orders.report-upload` (admin-web)	🟡 ontsluiten
AFB	`AfbPersonDocument` (gegenereerd en verzonden)	🟡 lezen ontsluiten
Anesthesieformulier	GVL Narcose-formulier	🟡 lezen ontsluiten
Medicatielijst	—	❌ (niet verplicht)

Wat ontbreekt in de API:

Ontwerp-operatie	Gap
`files.dossier` (alle documentregels van één traject of operatie, met status aanwezig/ontbreekt)	❌ `GET portal/trajectories/{id}/documents` en `GET portal/appointments/{id}/documents`, gegroepeerd per `document_type`
`files.open` (kortlevend ondertekend ticket)	🟡 de patiënt-download bestaat; voor medewerkers ❌. Advies: `URL::temporarySignedRoute` (5 min)
`files.upload` (gechunkt tot 500 MB, 8 MB per stuk)	🟡 patiënt-upload bestaat. Voor MRI-bestanden ❌ grote/gechunkte upload; eerst checken wat de maximale upload in onze stack is
`files.link` (externe MRI-viewerlink)	❌
`files.delete` (nooit voor gegenereerde documenten)	❌ met regel "uitvoer-documenten niet verwijderbaar"
Vaste lijst `document_type`-waarden	🟡 vrij veld in `additional`, ❌ enum
Documentcheck "verplicht voor aanmelding" (Diagnoseformulier, AFB, Anesthesieformulier, Arztbrief I)	❌ server-side afleiden, niet in de client

G-6a Recept → patiëntportaal (expliciete wens)

De Rezept Studio maakt een vergrendelde PDF ("_v2" bij een nieuwe versie). Wat het CRM moet doen:

1. ✅ File-activiteit op het traject (en/of de order) aanmaken: dit mechanisme bestaat.
2. ✅ Publiceren naar het patiëntportaal via `activity_portal_persons`. `GET patient/{id}/documents` toont het daarna.
3. ✅/🟡 `PatientNotification` maken: het mechanisme bestaat, het referentietype voor "recept" controleren.
4. ❌ Endpoint: `POST portal/trajectories/{id}/documents` met `document_type=recept`, `share_with_patient=true`. Idempotent op een client-key, zodat "Opnieuw versturen" geen tweede document maakt (het ontwerp eist dat).
5. ❌ Vergrendeling: een recept-activiteit is na aanmaken niet meer te wijzigen of te verwijderen.

Hetzelfde endpoint dekt ook Arztbrief en OP-bericht (zonder `share_with_patient`, of met, als dat later wordt besloten).

G-7 Dossier-chat (team) ❌

Ontwerp-operatie	CRM	Gap
`chat.list` / `counts` (berichten per dossier, ongelezen-tellingen per lijst)	notes op sales_lead	❌ geen draad, geen telling per gebruiker
`chat.create` / `reply` (draad met parent) + **@mentions** → melding bij de genoemde	—	❌ `parent_id` + mentions + melding (G-8)
`chat.attachment` (bijlage in bericht)	—	❌
`chat.delete` (alleen eigen bericht)	—	❌
`users.list` (namen en avatars voor mentions, geen e-mail)	—	❌ `GET portal/users` (alleen portaalgebruikers)

Let op: `PatientMessage` / `patient/{id}/messages` is de **patiëntchat** en blijft gescheiden. Dit is interne communicatie tussen zorgadviseur, arts en kliniek; die mag **nooit** bij de patiënt terechtkomen.

Advies: `Activity type=note` uitbreiden met `parent_id` en een `mentions`-pivot. Bouw geen nieuw berichtensysteem. Interne notities (`notes.*`) zijn dan hetzelfde type, maar zonder draad.

G-8 Meldingen voor medewerkers ❌

Ontwerp	CRM	Gap
`inbox.list` / `inbox.read` (persoonlijke meldingen: mention, antwoord, statuswissel)	`PatientNotification` alleen voor patiënten	❌ Laravel `notifications`-tabel (database channel) voor `User` + 2 endpoints

G-9 Home per rol ❌

Het ontwerp verwacht **per rol één samengestelde aanroep** met een vaste vorm (`{rol, datum, hint, taken[], perioden[], secties[]}`, zie `HOME_ROLSCHERMEN.md` §3).

Rol	Blokken	Bron in CRM (na de gaps hierboven)
Kliniek	Planning (deze/volgende week, per behandeltype) · Operaties vandaag (tijd, kamer, documentcheck) · Nieuwe aanmeldingen (docs compleet?) · Ontslag vastleggen	G-4 + G-5 + G-6
Arts	Te beoordelen · Vraag aan arts · Arztbrief nodig · OP-verslag nodig	G-3 (work_status)
Zorgadviseur	Beoordelingen gereed · Antwoord van de arts · Brieven klaar om te verzenden · Voorbereiding operaties · Uitgevoerde operaties · Consulten/nacontroles · Belstrip "morgen bevestigen"	G-3 + G-4 + G-5

Endpoints: `GET portal/home` (rol uit token) en optioneel `GET portal/home/version` (goedkope fingerprint voor polling, max `updated_at` over de relevante tabellen). Er bestaat al een vergelijkbaar aggregatiepatroon in `ClinicGuideController::get` en `OperationalDashboardController`; dat hergebruiken.

Advies: de server levert **data per blok**, de portal-frontend bepaalt teksten, kleuren en indeling. De `toon/kleur`-velden uit het monday-contract hoeven niet in de API.

G-10 Beheer 🟡

Ontwerp	CRM	Gap
`admin.users` / `assignRoles`	Webkul User + Role (admin-web) + Keycloak-sync (`UserObserver`)	✅ blijft in CRM-admin, geen API nodig
`admin.policy` / `savePolicy` / `schemaAudit` (veldclassificatie)	—	**niet bouwen**: dat is een monday-probleem (onbekende kolommen). In het CRM bepalen de API Resources wat zichtbaar is
`admin.security`, `bootstrap`, `oauthStart`, `setGuestValidation`	—	**niet bouwen**: monday-specifiek
Preview-als-rol (alleen lezen)	—	optioneel, laag

---

5. Wat niet gebouwd hoeft te worden

Deze zaken zijn monday-specifiek en hebben geen equivalent in het CRM nodig:

- `patients.schema` / `items` / `itemsByIds` / `itemsByRelation` / `operations.schema`: "vorm-compatibele" routes die monday-itemvorm nadoen. Het portaal krijgt gewone JSON-resources.
- de veldclassificatie (`UNCLASSIFIED`), board shielding, gastvalidatie en de OAuth-installatielink.
- weekgroepen, slotnummers en het chunken onder de Cloudflare-grens van 10 MiB, zolang onze eigen upload-route die grens niet heeft (te verifiëren).
- het monday-versiestempel per bord: vervangen door `updated_at`.

---

6. Voorgestelde API-oppervlakte (samenvatting)

Alle routes vallen onder `api/portal`, met Keycloak-bearer voor medewerkers, een rol uit de token/User, en Policies.

```
GET    portal/me                                  rol, capabilities, kliniek
GET    portal/home[/version]                      G-9
GET    portal/users                               G-7 (mentions)
GET    portal/trajectories                        G-2 werkvoorraad (arts: alleen toegekend, G-1a)
GET    portal/trajectories/{id}                   G-2
PATCH  portal/trajectories/{id}                   G-2 diagnose, beratung, regio, siehe chat
PUT    portal/trajectories/{id}/work-status       G-3
```

```
GET    portal/trajectories/{id}/appointments        G-4
GET    portal/trajectories/{id}/documents           G-6
POST   portal/trajectories/{id}/documents           G-6 / G-6a (incl. share_with_patient)
GET    portal/trajectories/{id}/messages            G-7
POST   portal/trajectories/{id}/messages            G-7 (parent_id, mentions)
DELETE portal/messages/{id}                         G-7
GET    portal/trajectories/{id}/notes   POST ...    G-7
GET    portal/appointments?from=&to=                G-4
GET    portal/appointments/{id}                     G-4
POST   portal/appointments                          G-4 plannen (operatie/consult/nacontrole)
PATCH  portal/appointments/{id}                     G-4 planning wijzigen
POST   portal/appointments/{id}/cancel              G-4
GET    portal/availability                          G-4 vrije capaciteit
GET    portal/appointments/{id}/clinical-record     G-5
PATCH  portal/appointments/{id}/clinical-record     G-5 (ontslag, kamer, anesthesie, medicatie)
GET    portal/appointments/{id}/documents           G-6
POST   portal/appointments/{id}/documents           G-6 (OP-bericht, AFB, ...)
GET    portal/documents/{id}/download               G-6 signed, kortlevend
POST   portal/documents/links                       G-6 externe MRI-link
DELETE portal/documents/{id}                        G-6 (niet voor uitvoer-docs)
GET    portal/notifications   POST .../read         G-8
```

≈ 27 endpoints. Patiënten en dossiers aanmaken blijft in het CRM. Dat is minder dan de helft als de ≈ 60 operaties in het ontwerp, omdat de monday-compatibele en beheer-operaties vervallen.

---

7. Datamodel-wijzigingen (samenvatting)

Wijziging	Gap
`salesleads`: `doctor_user_id` (FK users; verplicht voor Herniapoli) + backfill + CRM-rol Arts + toekennen in CRM-admin	G-1a
`users.clinic_id` (arts en kliniekgebruiker, één kliniek per gebruiker)	G-1a
`salesleads`: `region`, `diagnosis` (text), `treatment_advice` (text), `see_chat` (bool), `work_status` (enum)	G-2, G-3
`order_clinical_records` (nieuwe tabel, zie G-5)	G-5
`order_items`: optiestatus + `option_expires_at`	G-4
`activities`: `parent_id`, `document_type` als kolom/enum (nu `additional`), lock-vlag voor uitvoer-docs	G-6, G-7
`activity_mentions` (pivot user ↔ activity)	G-7
`notifications` (Laravel standaard, voor `User`)	G-8

Al deze wijzigingen raken meerdere modules en de auth-laag. Volgens de werkafspraken is dit **Architecture Mode**: eerst bespreken voordat er gebouwd wordt.

---

8. Voorgestelde volgorde

1. **G-1 + G-1a Auth, rollen en arts-toekenning**: zonder dit kan niets anders veilig open. De arts-toekenning in de CRM-admin kan al eerder live, los van het portaal.
2. **G-2 + G-3 Dossier + werkstatus**: daarmee kan de arts zijn hele flow doen (lezen, diagnose, status).
3. **G-6 + G-6a Documenten + recept naar patiëntportaal**: de expliciete wens; hergebruikt het bestaande portal-publish.
4. **G-4 + G-5 Planning + operatierecord**: het kliniekscherm en de planning van de zorgadviseur.
5. **G-9 Home per rol**: pas als de bronnen er zijn.
6. **G-7 + G-8 Chat + meldingen**: grootste nieuwe concept; eerst nagaan of de huidige notes voorlopig volstaan.

---

9. Acties / stories

Auth, rollen en toewijzing (G-1, G-1a)

1. Kliniek koppelen aan gebruiker (`users.clinic_id`) + beheer in CRM-admin
2. CRM-rol Arts + Keycloak-rol
3. Arts toekennen aan Herniapoli-sale (`doctor_user_id`) in CRM-admin
4. Backfill arts op bestaande Herniapoli-sales
5. Arts verplicht vanaf "Casus bij arts ter beoordeling"
6. Portaal-auth voor medewerkers (`api/portal`, Keycloak-bearer, rol uit User)
7. Zichtbaarheid per rol (query-scope + Policies)
8. `GET portal/me`

Dossier en werkstatus (G-2, G-3)

9. Medische velden op sale: regio, diagnose, Behandlungsberatung, Siehe Chat
10. Werkstatus als aparte kolom (10 statussen)
11. Werkvoorraad-endpoint (lijst trajecten)
12. Dossier-endpoint (detail traject)
13. Dossiervelden wijzigen met conflictcontrole
14. Werkstatus wijzigen met sluitcontrole

Documenten (G-6, G-6a)

15. Vaste documentsoorten (`document_type`-enum)
16. Documenten per traject en per operatie, met check aanwezig/ontbreekt
17. Document uploaden vanuit portaal (Arztbrief, OP-bericht, ...)
18. Recept opslaan, vergrendelen en delen met patiëntportaal (idempotent)
19. Kortlevende download-links voor medewerkers
20. Externe MRI-viewerlink toevoegen
21. Document verwijderen (niet voor gegenereerde documenten)
22. Grote uploads (MRI) uitzoeken

Planning en operatierecord (G-4, G-5)

23. Intake-datum en aankomsttijd: plek in datamodel bepalen (V8)
24. Afspraken-overzicht per periode
25. Afspraak-detail en afspraken per traject
26. Beschikbaarheid ontsluiten
27. Afspraak plannen (operatie, consult, nacontrole)
28. Status Optie met vervaldatum + automatisch vrijgeven
29. Afspraak annuleren met reden
30. Kliniek van resource moet gelijk zijn aan kliniek van arts bij boeken
31. Klinisch operatierecord (kamer, OP-tijd, ontslag, medicatie, anesthesie)
32. Operatierecord lezen/wijzigen met veldrechten per rol

Home (G-9)

33. Home Kliniek
34. Home Arts
35. Home Zorgadviseur
36. Home-versie voor polling

Chat en meldingen (G-7, G-8)

37. Dossier-chat met draad en @mentions
38. Gebruikerslijst voor mentions

39. Meldingen voor medewerkers (inbox + gelezen)

---

10. Open vragen

#	Vraag	Waarom het uitmaakt
~~V1~~	~~Patiëntbegeleider in het portaal?~~	**Besloten: nee**
~~V2~~	~~Scope arts en kliniek~~	**Besloten:** arts via toekenning aan sale, kliniek via arts → kliniek (G-1a)
~~V3~~	~~Patiënten en dossiers aanmaken in het portaal?~~	**Besloten: blijft in het CRM**
V4	Wie beheert de **operatiecapaciteit**: het portaal (ontwerp: alle rollen) of alleen de CRM-admin (Resources/Shifts)?	Bepaalt of G-4-capaciteit überhaupt een API nodig heeft
V5	Eén operatie per Order, of kan één Hernia-order meerdere operaties bevatten?	Bepaalt of het klinisch record aan `orders` of `order_items` hangt
V6	Welke bron is leidend voor het **diagnoseformulier**: `leads.diagnoseform_pdf_url` of het Anamnesis-formulier uit het patiëntportaal?	Er zijn nu twee paden
V7	Moeten Arztbrief en OP-bericht ook naar het patiëntportaal, of alleen het recept?	Bepaalt de default van `share_with_patient`
V8	Waar leven **intake-datum** en **aankomsttijd**: `orders.first_examination_at/_time` of een eigen orderregel?	Nodig voor het kliniekscherm (Home en weekplanning)
~~V9~~	~~"CRM integratie geparkeerd" in het monday project~~	**Oud besluit, vervalt**
~~V10~~	~~Aantal artsen per sale~~	**Besloten:** één arts per sale, verplicht, alleen Herniapoli
~~V11~~	~~Moment van verplichting~~	**Besloten:** verplicht bij de overgang naar "Casus bij arts ter beoordeling", niet bij het aanmaken
~~V12~~	~~Eén of meer klinieken per arts~~	**Besloten:** één kliniek per arts → `users.clinic_id`